

RECURSO CÍVEL Nº 5074480-49.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: ISABEL DA CONCEICAO LEIA REIS (AUTOR)

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ADMINISTRATIVO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - OSTEOPOROSE - DENOSUMABE - MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS PARA O CASO DO AUTOR - MEDICAMENTO EXPRESSAMENTE NÃO INCORPORADO AO SUS PARA O TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE - RESERVA DO POSSÍVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DE REJEIÇÃO AO TRATAMENTO PADRONIZADO - PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA - TEMA 106 DO STJ - TEMA 6 DO STF - NÃO BASTA A SIMPLES ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO, MESMO QUE ACOMPANHADA DE RELATÓRIO MÉDICO, SENDO NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE QUE A OPINIÃO DO PROFISSIONAL ENCONTRA RESPALDO EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL - ARGUMENTAÇÃO QUE DEVE SER REFORÇADA QUANDO TRATAR-SE DE FÁRMACO EXPRESSAMENTE NÃO INCORPORADO AO SUS POR DECISÃO DA CONITEC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA UTILIZAÇÃO DA TERIPARATIDA - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, mantendo a sentença. Condene o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedida a gratuidade, fica a parte isenta das custas processuais (art. 4º, II, da Lei 9.289/1996) e suspensos os honorários advocatícios (art. 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 - CPC; art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95; art. 54, parágrafo único, in fine, da Lei 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se, inclusive ao MPF. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5074480-49.2024.4.02.5101

510015425335 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5074480-49.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: ISABEL DA CONCEICAO LEIA REIS (AUTOR)

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial e reiterado em sede recursal, tendo em vista a declaração firmada e os contracheques apresentados, com fundamento no Enunciado nº 119 das Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro:

ENUNCIADO 119 - "O pedido de gratuidade de justiça pode ser analisado pela Turma Recursal quando do conhecimento de recurso interposto sem preparo, desde que esteja acompanhado de declaração de hipossuficiência nos termos do art. 2º da Lei 1.060/50." (Aprovado na Sessão Conjunta de 03/12/2013. Publicado no DJ-e de 18/12/2013, pg 1.363).

Em suma, a pretensão consiste na concessão do medicamento DENOSUMABE para tratamento de osteoporose.

Trata-se de parte autora do sexo feminino, atualmente com 79 anos, em acompanhamento pelo Hospital Federal de Ipanema. A informação médica de fl. 17 do evento 1, ANEXO2 afirma que fez uso de medicações disponibilizadas pelo SUS (ácido zoledrônico, calcitonina, raloxifeno, calcitriol, romosozumabe), mas evoluindo sem melhora da densitometria.

O juízo de origem julgou **improcedente o pedido**.

Em sede recursal, a recorrente pugna pela reforma da sentença, requerendo, com urgência, o fornecimento do medicamento denosumabe 60 mg.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, que a obrigação da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária, de maneira que qualquer um dos referidos entes federativos pode figurar no polo passivo de demanda em que se objetiva assegurar o fornecimento ou custeio de medicamentos ou tratamento médico. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(STF, Pleno, RE 855178 RG/PE, Relator Ministro LUIZ FUX, publicado em 16/03/2015).

Além disso, o entendimento quanto à legitimidade da União e, *mutatis mutandis*, também dos demais entes federados encontra-se, inclusive, sedimentado no Enunciado nº 43 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais desta Seção Judiciária do Rio de Janeiro, *in verbis*:

Enunciado 43: “A União é parte legítima nas demandas que visem assegurar o direito às prestações do Sistema Único de Saúde - SUS”.

A descentralização administrativa dos serviços e recursos financeiros tem por fim tão somente o de melhorar a qualidade e o acesso à saúde, e não pode se prestar para afastar a responsabilidade de quaisquer dos entes. Pelo contrário, reforça a responsabilidade solidária, pois indica o trabalho conjunto para perseguir o fim constitucional.

O exame da questão passa pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, na STA em AgRg 175, onde aquele explicou que o Sistema Único de Saúde filiou-se à corrente da “Medicina com base em evidências”, de modo que **um medicamento ou tratamento em desconformidade com o Protocolo deve ser visto com cautela**, pois tende a contrariar consenso científico vigente. Mais do que isso: a gestão do SUS, obrigado a observar o princípio constitucional do acesso universal e igualitário às ações de saúde, só se torna viável mediante a elaboração de políticas públicas que repartam os recursos (naturalmente escassos) da forma mais eficiente possível. **Obrigar a rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS**, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela da população mais necessitada.

Dessa forma, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida, **sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente**.

Com isso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que **o deferimento pelo Judiciário de medicamento extraordinário fora do âmbito do SUS, deve ficar restrito a hipóteses de rara e especial excepcionalidade**:

(a) quando a enfermidade do paciente não for tratada pelo SUS, ou;

(b) quando o tratamento/medicamento disponibilizado pelo SUS não tiver eficácia comprovada no caso concreto.

Caso não se inclua nestas hipóteses, **pelo fato de o SUS disponibilizar gratuitamente outros medicamentos para o tratamento da enfermidade**, não há que se falar em deferimento pelo Judiciário, sob pena de prejudicar, conforme já explicitado, o acesso universal e isonômico à saúde. E isto porque a opção pelo medicamento listado leva em consideração outros fatores: o **custo, a eficácia comprovada e a incidência sobre a patologia tratada, de modo a beneficiar a maior parte da população**. Assim, a Administração Pública adota critérios plausíveis quando incorpora um medicamento à listagem daqueles que serão gratuitamente distribuídos, sendo inviável ignorá-los a fim de satisfazer a demanda de uma pessoa isoladamente.

Por tal razão, não cabe ao Judiciário ingerência sobre prioridades estabelecidas pelo Estado, que envolvam políticas públicas para garantir o regular atendimento e fornecimento de medicação na rede de saúde, sob pena de, por via transversa, criar situação de inaceitável desigualdade em relação aos demais usuários do SUS. O posicionamento acima é compartilhado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

*CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO ESPECÍFICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. União, Estados e Municípios, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são responsáveis solidários pelo fornecimento de medicamentos. **Não faz jus ao fornecimento de medicamentos pelo Poder Público o paciente que não se desincumbe de comprovar a real necessidade dos mesmos e a impossibilidade de substituí-los por outros disponibilizados pelo SUS.** Inversão da sucumbência, que é fixada na esteira dos precedentes da Turma. Prequestionamento estabelecido pelas razões de decidir. Apelações e remessa oficial providas. (apelação nº 0006160-45.2008.404.7200)*

Conclui-se, portanto, que é necessário demonstrar que **o tratamento fornecido pelo SUS não é adequado para controle da enfermidade da parte requerente para que, então, possa se fugir ao padrão e deferir terapia diversa, não havendo margem para escolha de tratamento que mais lhe aprouver**, desconsiderando as terapias já ofertadas pela Administração Pública, a partir da mera discricionariedade médica, ainda que o profissional esteja vinculado ao SUS.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese, em sede de representativo de controvérsia (tema 106)[1], no sentido de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença **cumulativa** dos seguintes requisitos[2]:

(a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(c) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência.

De outro giro, é dizer: o Superior Tribunal de Justiça ratificou os requisitos já fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no que tange à prova de ineficácia do tratamento dispensado pelo SUS, e incluiu 2 novos, quais seja, a hipossuficiência econômica do requerente e o registro do medicamento na ANVISA, afastando, assim, o fornecimento de fármacos cuja eficácia não tenha sido atestada por órgãos de controle.

Em 26/09/2024, sem modulação dos efeitos da decisão, em sede de repercussão geral, no âmbito do RE 566471, Redator do acórdão: MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO, o STF fixou as seguintes teses (**Tema 6 da repercussão geral** - RE. DJE divulgado em 27/09/2024, publicado em 30/09/2024.):

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Por fim, determinou, tal como no Tema 1.234, que essas teses sejam transformadas em enunciado sintetizado de súmula vinculante, na forma do art. 103-A da Constituição Federal, com a seguinte redação (Enunciado publicado no DJE e no DOU em 03/10/2024):

Súmula vinculante nº 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

A tese do Tema 6 - STF estabelece uma regra geral: a ausência de um medicamento nas listas oficiais do SUS impede, em princípio, seu fornecimento por decisão judicial (item 1 da tese). Trata-se de uma deferência judicial às políticas públicas de saúde fixadas pelo Poder Executivo, dado que as listas não são criadas casuisticamente, mas, sim, a partir de análises técnicas embasadas em critérios técnico-científicos e de custo-efetividade dos fármacos.

Entretanto, o STF estabeleceu os parâmetros para excepcionalização da referida referida regra, quais sejam (item 2 da tese):

1. **A comprovação de negativa administrativa prévia;**
2. **A demonstração de ilegalidade ou omissão no processo de incorporação do medicamento;**
3. **A inexistência de alternativas terapêuticas no SUS;**
4. **A comprovação científica robusta da eficácia e segurança do medicamento;**
5. **A demonstração da imprescindibilidade do tratamento;**
6. **A comprovação da hipossuficiência financeira do paciente.**

A alínea a do item 2 da tese remete ao item '4' do Tema 1.234 da repercussão geral (" (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;"), o qual prevê que:

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, **deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.**

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

No caso concreto, a autora, do sexo feminino, com 79 anos, está em acompanhamento pelo Hospital Federal de Ipanema. A informação médica de fl. 17 do evento 1, ANEXO2 afirma que fez uso de medicações disponibilizadas pelo SUS (**ácido zoledrônico, calcitonina, raloxifeno, calcitriol, romosozumabe**), mas evoluindo sem melhora da densitometria. A fl. 18 do mesmo documento relata que a parte autora, **além da osteoporose e do histórico de fratura, realiza tratamento com Denosumabe a cada 6 meses e necessita da medicação para prosseguir com o tratamento.**

Atualmente, existem dois fármacos disponibilizados pelo SUS aplicáveis, em tese, ao caso da autora: o Romosozumabe, incorporado ao SUS por meio da PORTARIA SCTIE/MS Nº 166, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2022, e a Teriparatida, incorporada ao SUS pela PORTARIA SCTIE/MS Nº 62, DE 19 DE JULHO DE 2022. O atual PCDT da Osteoporose foi aprovado pela PORTARIA CONJUNTA Nº 19, DE 28 DE SETEMBRO DE 2023, o qual confirma como alternativas terapêuticas ambos os fármacos (Romosozumabe e Teriparatida).

A autora afirma que já fez uso prévio dos fármacos ácido zoledrônico, calcitonina, raloxifeno, calcitriol, romosozumabe, sem sucesso. **Portanto, não teria testado ainda o medicamento Teriparatida.**

A PORTARIA SCTIE/MS Nº 166, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2022 publicou a decisão de incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, o romosozumabe para mulheres com osteoporose na pós menopausa, a partir de 70 anos, que apresentam risco muito alto de fratura por fragilidade e que falharam (apresentaram duas ou mais fraturas) com o padrão de tratamento medicamentoso, conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Já a PORTARIA SCTIE/MS Nº 62, DE 19 DE JULHO DE 2022, publicou a decisão de incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a teriparatida para o tratamento de indivíduos com osteoporose grave e falha terapêutica aos medicamentos disponíveis no SUS, conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, **E DE NÃO INCORPORAR, NO ÂMBITO DO SUS, O DENOSUMABE PARA O TRATAMENTO DE INDIVÍDUOS COM OSTEOPOROSE.**

Com efeito, a concessão do DENOSUMABE vai de encontro ao Tema 106 do STJ e está em contrariedade ao atual Tema 6 do STF, dado que ausente comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, **especialmente da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS (Teriparatida).**

Existindo outros fármacos em tese igualmente eficazes para o tratamento da saúde da autora, caberia a ela desmonstrar a sua ineficácia, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente quanto a Teriparatida.

A CONITEC recomendou a não incorporação do denosumabe para o tratamento de osteoporose, **considerando o alto risco de viés nos estudos, o que fragilizaria os resultados e as evidências seriam de baixa qualidade. Desse modo, a avaliação não apontou diferença significativa quanto ao risco de fratura entre pacientes em uso de denosumabe comparado ao placebo no tratamento da osteoporose.**

Em igual sentido, não foi demonstrada falha ou ilegalidade da análise da CONITEC que decidiu por não incorporar o fármaco ora requerido, o que também contraria o tema supra citado do STF. Consoante o Tema 6 do STF, a análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

Na mesma linha, nos termos do Tema 6 do STF, **tratando-se de medicamento não incorporado, é da parte da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento**, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra **respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.**

Por último, diante das informações disponíveis nos autos, os medicamentos Romosozumabe e Teriparatida, incorporados ao SUS, não apresentariam contra-indicação de uso para autora, em princípio.

[1] Lei nº 8.080/90:

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea *d* do inciso I do art. 6º consiste em: **(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)**

I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravamento à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P; (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)

II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado.

Art. 19-P. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada: **(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)**

I - com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite; **(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)**

II - no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite; **(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)**

III - no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde. **(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)**

[2] ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glauco 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.

2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.

3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a **presença cumulativa dos seguintes requisitos**: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

(STJ, REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA**, mantendo a sentença. Condene o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedida a gratuidade, fica a parte isenta das custas processuais (art. 4º, II, da Lei 9.289/1996) e suspensos os honorários advocatícios (art. 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 - CPC; art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95; art. 54, parágrafo único, in fine, da Lei 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se, inclusive ao MPF. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.